2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo

30 de abril a 2 de maio de 2026

MACEIÓ • ALAGOAS

Realização

ABEFACO AAMFC

Associação entre Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica ao Risco de Evento Cardiovascular em Pacientes da Atenção Primária à Saúde

Uly Miranda Pereira (1), Yorrana Freitas Ribeiro (2), Manoel Messias Alves de Souza (3), Álvaro Luís Müller da Fonseca (4)
(1) Graduanda em Ciências Biológicas; Laboratório de Imunologia e Epidemiologia (LAIM), Departamento de Educação (UNEB, DEDC-7)
(2) Graduanda em Enfermagem (UNEB), Laboratório de Imunologia e Epidemiologia (LAIM), Departamento de Educação (UNEB, DEDC-7)
(3) Doutor em Educação, Colegiado de Ciências da Natureza, Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
(4) Professor Titular-Pleno; Doutor em Biotecnologia e Medicina Investigativa, Laboratório de Imunologia e Epidemiologia (LAIM), Departamento de Educação (UNEB, DEDC-7), alfonseca@uneb.br

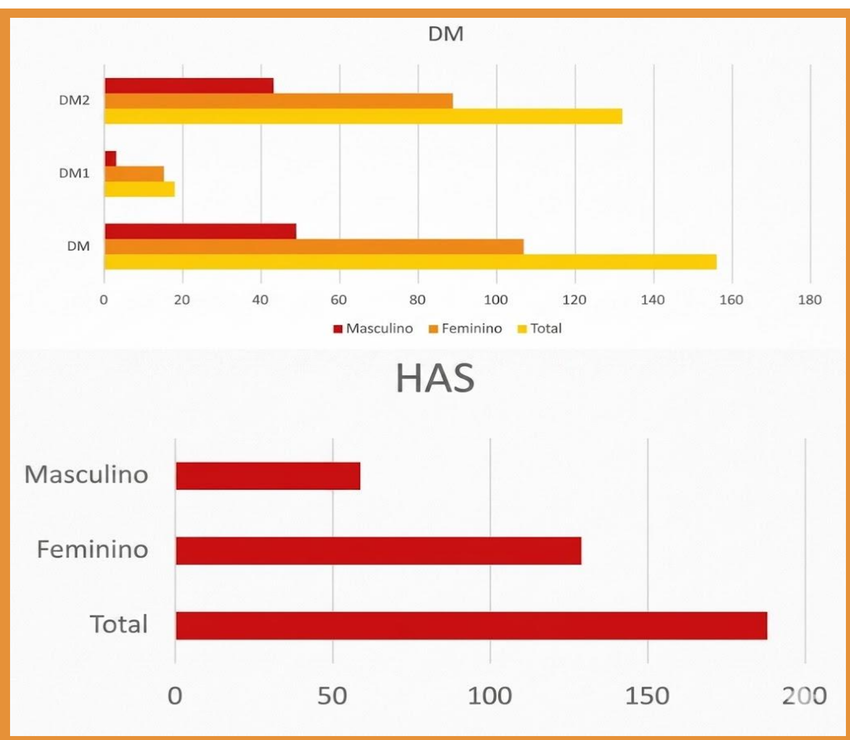


FIG 1: Representação dos tipos de Diabetes Mellitus e distribuição dos casos de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) na população analisada.

PRINCIPAIS ACHADOS DO TRABALHO

Observou-se predominância do sexo feminino e da raça parda na população analisada, com maior frequência de casos em indivíduos idosos, especialmente a partir dos 65 anos. Além da forte associação entre as duas condições, principalmente relacionada ao DM tipo 2, indicando coexistência clínica.

Introdução

O diabetes mellitus é uma doença crônica, que altera o processamento da glicose. Nesse âmbito, é importante a diferenciação dos tipos de diabetes: o Diabetes insipidus (DI) resulta na falha renal, levando à sede intensa; Diabetes gestacional (DG), que surge no segundo trimestre de gravidez e aumenta o risco de DM2 futuramente; Diabetes mellitus 1 (DM1) diagnosticado na infância, requer o uso de insulina contínua, e Diabetes mellitus 2 (DM2), mais frequente, é relacionado ao estilo de vida. As DM e DG consistem em resistência ou intolerância à insulina e metabolismo insuficiente da glicose tecidual. Em especial no DM, o risco cardiovascular e complicações visuais e circulatórias ocorrem. Além do DM, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica caracterizada por altos níveis de pressão sanguínea. Essa medida é identificada por um nível de pressão arterial elevada (acima de 120 por 80), constituindo-se um dos principais fatores de desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV). Consequentemente, é importante compreender quais fatores de risco estão associados a essas doenças.

Ao analisar, tanto DM como HAS, fica evidente a identificação de padrões em ambas, os quais aumentam o risco cardiovascular (RCV), porém, seu monitoramento auxilia na prevenção, mitigação do risco e melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Objetivos

O estudo analisa a ocorrência de DM e HAS, considerando perfil clínico, sociodemográfico e padrões que indiquem maior risco e vulnerabilidade.

Métodos

A metodologia consistiu na análise de planilhas de dados do prontuário eletrônico de saúde e atenção primária. Os dados foram analisados por estatística descritiva, levando em conta variáveis: fatores sociodemográficos, clínicos e laboratoriais, além da presença de HAS, DM1/DM2 e outras comorbidades.

Resultados

Embora a base de dados contenha diversas variáveis, a análise neste resumo se concentra na frequência de diabetes e hipertensão, considerando a quantidade total e classificada por gênero de indivíduos afetados, diferenças de idade e raça.

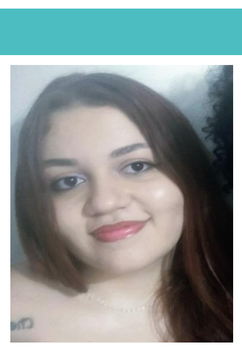
A população analisada mostra-se predominantemente feminina (68%) e predominância da raça parda. A faixa etária mais recorrente é de 65 anos, repetindo-se entre mulheres, entre homens, majoritariamente, 74 anos. O estudo inclui 144 (68,9 %) mulheres e 65 (31,1 %), homens (n = 209). As patologias associadas, HAS e DM, revelam tendência significativa, alcançando 144 (68,9%) indivíduos, indicando tendência ao alto RCV, especialmente em DM2 concomitante à presença de HAS. A ocorrência de HAS (188 casos, 89,9%) e de DM (156 casos 74,4%) reflete sua distribuição proporcional entre os gêneros. Destaca-se que há uma forte tendência de associação entre as duas condições: 92% dos diabéticos têm HAS e 76% dos hipertensos apresentam DM, evidenciando correlação e confluência clínica, associadas ao DM2.

Conclusão/Considerações finais

A população estudada aponta para uma tendência a alto RCV, causado pelo conjunto de HAS e DM, em sua maioria mulheres e pessoas idosas. As análises obtidas são de grande importância para mapear a população e identificar padrões decorrentes desse panorama. Portanto, mostra-se necessário o monitoramento constante dos pacientes, com avaliação de RCV, o diagnóstico precoce e tratamento eficaz. Futuramente, estimativas de escore de risco serão calculadas e correlações de risco interseccionais serão estabelecidas entre os fatores sociodemográficos e clínicos.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
ULY MIRANDA PEREIRA
DISCENTE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – UNEB/DEDC VII

E-mail: mziiranda@gmail.com
Contatos: 74999268878



UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA